L'Auto-développement : 20 ans plus tard

par Michelle Larivey et Jean Garneau, psychologues

La première édition de ce document a été publiée dans
La revue québécoise de psychologie
(Vol. 20, No 2, 1999, pp 65-96)

Table des matières

Avertissement

Introduction

I. Une théorie du vivant
- A- La vie comme valeur primordiale
- B- Une conception du vivant

II Le processus de changement
- A- Un nouveau nom
- B- Un même processus, une nouvelle vision de la croissance
  - 1- La croissance : résultat d'une adaptation
  - 2- La hiérarchie des besoins revue
  - 3- Adaptation au sens de synthèse organismique

III. Une théorie des émotions
- A- Une conception des émotions
- B- Une typologie des phénomènes émotifs
  - 1. Les émotions simples
  - 2. Les émotions mixtes
  - 3. Phénomènes émotifs résultant d'émotions repoussées
  - 4. Pseudo-émotions

IV. La résolution du transfert
- A- Les acquis antérieurs
- B- L'insight nouveau
- C- Le transfert actif: un axe de croissance

V. Un psychodiagnostic humaniste
- A- Un diagnostic en trois volets
  - 1- Le volet du processus
  - 2- Le volet du transfert
  - 3- Le volet existentiel

B- L'utilité particulière du diagnostic humaniste

VI. L'intervention à distance
A- Les programmes d'auto-développement
B- "La lettre du Psy"

Conclusion
A- Une inquiétude
1- Une question d'attitude
2- Un contexte économique
B- Une voie de solution possible

Références

Avertissement

On nous a invités à décrire notre évolution, comme humanistes, en rapportant les questions et les expériences personnelles qui l'ont marquée. Mais il est difficile de retrouver notre questionnement individuel et de l'imbriquer à celui de l'autre quand on signe à deux un texte comme celui-ci. Cela est d'autant plus difficile que l'Auto-développement s'est élaboré, pour une large part, grâce aux échanges que nous avons eus avec d'autres psychothérapeutes et avec des stagiaires en formation. Il nous serait impossible de rendre compte des nombreux méandres de ces discussions.

En tant que praticiens, ce ne sont pas les questions qui ont d'abord servi de moteur à notre évolution mais bien les problèmes. C'est pourquoi cette article fera davantage part des solutions que nous avons inventées, issues d'une meilleur compréhension des phénomènes ou visant à maximiser l'efficacité de nos interventions. En tant que praticiens, notre questionnement prend donc une forme plus "éclatée" que celui d'un chercheur: il est ponctué de problèmes concrets auxquels nous cherchons constamment des réponses immédiatement applicables.

Introduction

En 1979, nous avons publié la synthèse de notre compréhension de la psychothérapie. Elle prenait la forme d'une nouvelle approche qui s'inscrivait dans le courant humaniste : l'Auto-développement. Une vingtaine d'années plus tard, cette invitation à contribuer à un numéro sur l'évolution du courant humaniste-existentiel au Québec est l'occasion de faire connaître à nos collègues les nouveaux développements survenus depuis dans nos conceptions et notre pratique. Nous avons en effet très peu publié à l'intention des professionnels pendant cette période (Garneau 1980, Garneau 1984, Larivey et Garneau 1996). Nos efforts principaux ont été consacrés au grand public et aux psychothérapeutes à qui nous dispensons de la formation.

Ce regard en arrière nous amène à constater que notre conception s'est beaucoup épurée au cours de ces vingt ans. Certaines de nos découvertes ont engendré des changements majeurs dans notre pratique, notamment en ce qui concerne la résolution du transfert. Elles nous ont ensuite conduits à une nouvelle articulation de notre conception de la croissance, cette fois, autour du concept du vivant.

Cette préoccupation de cerner ce qui caractérise la vie elle-même nous a amenés à reconsidérer l'échelle des besoins présentée par A. Maslow et du même coup, la nature même de ce que nous appelions, autrefois, le "processus naturel de croissance". Notre vision du développement nous incite à l'appeler maintenant "processus vital d'adaptation".

Dans le but de maximiser l'efficacité de nos interventions, nous avons dû approfondir également notre compréhension de la vie émotive. Cela a donné lieu à une théorie sur les émotions. Finalement, par

souci de consistance et d'efficacité, il nous a fallu concevoir un système diagnostic qui soit capable de guider nos interventions tout en s'harmonisant avec l'ensemble de notre conception. Ce travail a donné lieu à un système intégrant les trois dimensions sur lesquelles porte l'intervention soit, le processus, le transfert et les dénis existentiels.

Le contexte social dans lequel nous travaillons évolue lui aussi. Il nous présente de nouveaux défis en nous exposant à de nouvelles problématiques auxquelles nous devons apporter des réponses dans une perspective humaniste. L'application de notre compréhension du fonctionnement humain et de son développement à diverses clientèles et à divers milieux nous a amenés à développer des formes d'intervention originales dans des secteurs comme l'intervention post-traumatique individuelle et de groupe et la gestion des conflits en entreprise.

Enfin, l'épuration de notre pratique nous amène à développer des interventions à distance. Celles-ci constituent la concrétisation la plus pure de l'objectif fondamental qui caractérise l'Auto-développement : l'instrumentation. Avec la démocratisation récente d'outils de communication puissants qui abolissent plusieurs frontières, il devient impérieux d'aller encore plus loin dans cette direction.

I. Une théorie du vivant

A- La vie comme valeur primordiale

Adhérant à la perspective phénoménologique, les approches du courant humaniste mettent la *personne* au centre de leurs préoccupations. Dans cette perspective, la personne est sa propre raison d'être et sa valeur la plus importante, considérant que la vie a déjà, en elle-même, son sens et sa valeur. Certaines approches de ce courant ont comme objectif thérapeutique d'augmenter la vitalité psychique. L'objectif premier de l'Auto-développement est l'instrumentation, mais il s'agit d'une instrumentation permettant de vivre sa vie en étant vivant.

Comme psychothérapeutes humanistes, nous optons pour *le respect de la personne humaine dans toute sa dignité et nous privilégions la vie.* Nous tentons de donner à nos clients l'instrumentation nécessaire pour devenir pleinement vivants, de la façon particulière qui en fait des personnes aussi complètement humaines que possible. C'est clairement dans ce qu'on intitulait autrefois le "mouvement du potentiel humain" et la "troisième force" que nous sommes inscrits, mais d'une façon bien particulière qui vise à favoriser et à maximiser le caractère vivant des personnes.

B- Une conception du vivant

Entre 1976 et 1984, nous avons contribué, comme consultants, à l'élaboration de programmes visant le développement affectif et social dans le cadre des activités scolaires. C'est durant ces années que nous avons réfléchi en profondeur sur les caractéristiques du vivant. Nous proposions en effet, au Ministère de l'Éducation du Québec, un programme s'étendant sur douze années de formation. Le programme visait l'objectif suivant chez l'élève: *"devenir capable de faire des choix libres et responsables, éclairés par le respect de la vie*". Les objectifs du programme, la démarche ou le processus pour y parvenir ont été définis en détails. Une équipe d'éducateurs a développé le matériel pédagogique et des enseignants ont reçu la formation pour travailler dans cette perspective. Bref, durant plusieurs années nous avons **élaboré et concrétisé cette théorie**. Ce fut une expérience enrichissante qui a largement influencé notre pratique de la psychothérapie en nous permettant d'articuler une conception du vivant.

On sait que plusieurs approches du courant humaniste visent à augmenter la vitalité. Toutefois, le concept de vitalité demeure souvent relativement flou. On y parle d'énergie, de ressenti, d'expression. L'articulation d'une conception du vivant nous a permis d'établir des cibles d'intervention précises pour augmenter la vitalité de l'individu, du couple, des groupes...Pour y arriver, nous avons tenté de cerner les *caractéristiques du vivant en général et de l'humain en particulier*. Nous avons également tenté de préciser leur articulation dans un système qui semble universel.

Il serait trop long de présenter ici cette théorie. Elle est disponible par ailleurs (Garneau et Larivey, 1999).

II Le processus de changement

Notre souci de comprendre le changement personnel a été un des moteurs importants du développement de notre approche. Au début des années '70, les sessions de croissances personnelle (alors dirigées par des professionnels) étaient très populaires. À cette époque, nous avons souvent été sidérés d'entendre les participants déplorer le fait qu'ils ne pouvaient vivre aussi pleinement dans leur vie quotidienne qu'en session.

Les gens déploraient la rareté du "contact réel" dans la vie courante, le manque d'intensité dans leurs relations inter-personnelles. Il semblait aussi que les changements importants de leur personne ne se produisaient que dans le creuset des groupes de croissance ou de la psychothérapie. En guise de solution, ils participaient à de nombreuses sessions, comme si la vie réelle se passait dans ces contextes protégés. Les "communes thérapeutiques" se mirent à voir le jour, les "mouvements thérapeutiques" aux allures de sectes et les gourous de la croissance se multiplièrent.

Nous étions troublés par ces phénomènes. À nos yeux, c'est dans la vie courante qu'il est important de vivre pleinement. C'est la vie qui offre les défis de se réaliser. C'est dans la vie de tous les jours, avec nos intimes, avec les amis et au travail qu'il est important de vivre des relations nourrissantes.

C'est devant cette réalité qu'a commencé à germer en nous l'idée d'instrumenter nos clients pour qu'ils puissent diriger leur cheminement comme nous, les experts, le dirigions en session ou en thérapie. C'est la que nous avons commencé à nous soucier de "transmettre notre expertise sur le changement" à nos clients. L'Auto-développement naissait.

Le processus de changement fut notre premier sujet d'étude approfondie. Nous avons étudié longuement le cheminement de plusieurs de nos clients pour comprendre à travers quelles expériences leur changement durable s'était produit. Ce travail nous a amenés à compléter les conceptions de E.T. Gendlin (*Experiencing et processus de Focusing)* et celle des Gestaltistes, (*le processus de formation de destruction des Gestalt*). Nos efforts de conceptualisation ont conduit à la formulation du ***processus naturel de croissance***. Celui-ci est présenté et expliqué en détail dans "L'Auto-développement: psychothérapie dans la vie quotidienne" (Garneau et Larivey, 1979).

Ce processus nous semble, encore aujourd'hui, correspondre au cheminement naturel d'une préoccupation ou d'une émotion. Lorsque l'expérience vécue n'est pas conflictuelle, l'émotion passe tout naturellement par les six étapes de ce processus: émergence, immersion, développement, prise de signification, action unifiante et pré-émergence.

Mais ce sont les mêmes étapes qui permettent de comprendre comment se font le changement personnel et la résolution des conflits psychiques. Le changement et l'intégration de l'expérience se produisent à travers l'action unifiante, l'étape qui fait suite à la prise de signification de l'expérience ("insight"). Cette action "unifiante" prend la forme d'une action (ou expression) dont la caractéristique principale est de **respecter entièrement l'expérience et de l'assumer**.

Nous pensons que c'est selon ce processus que les humains continueraient de vivre leurs expériences émotives s'il ne faisaient volontairement pas des choix défensifs qui l'altèrent. Les habiletés nécessaires à chacune des étapes de ce processus sont sous-développées ou même perdues au cours du développement de l'individu. L'éducation est un facteur d'influence primordial qui supporte ces choix d'évitement.

Un des principaux objectifs de la psychothérapie en Auto-développement est de permettre à ce processus de fonctionner d'une façon optimale. C'est ce qui permettra éventuellement à la personne de grandir à travers toutes ses expériences, même celles qui sont conflictuelles.

A- Un nouveau nom

En vingt ans, notre description de ce processus n'a pas subi de correction majeure. Le seul changement concerne l'étape de la *pré-émergence*. Nous voyons maintenant qu'il ne s'agit pas d'une étape au même titre que les autres. Nous attribuons maintenant au début de l'émergence elle-même, les caractéristiques de la pré-émergence. Nous continuons cependant à traiter cette dernière comme une étape du processus à cause de son utilité pour le diagnostic. Elle sert, entre autres, à identifier les divers symptômes du blocage de l'expérience au moment de l'*émergence*.

Ces années de travail thérapeutique nous ont confirmé l'existence du processus conceptualisé au début des années '70. Mais nous en avons maintenant une compréhension beaucoup plus approfondie. Nous avons identifié avec précision, les diverses attitudes, habiletés et connaissances exigées par chacune des étapes. Nous pouvons maintenant faire, avec plus de précision, le diagnostic des défectuosités du processus et des résistances du client. Ceci a pour conséquence un raffinement accru dans la facilitation du processus et l'instrumentation du client.

Mais le changement le plus important de notre vision concerne la fonction de ce processus. Au moment de son élaboration, nous pensions qu'il régissait la "croissance". Nous pensons maintenant qu'il s'agit d'un **processus d'adaptation** C'est pour cela que nous en avons changé le nom. En fait, le processus n'a pas changé. C'est notre vision du développement personnel qui s'est modifiée.

B- Un même processus, une nouvelle vision de la croissance

1- La croissance : résultat d'une adaptation

Notre vision du processus et de sa facilitation n'a pas changé de façon importante, mais notre expérience nous a conduits à une nouvelle vision de la croissance psychique. Il est en effet devenu clair pour nous que la croissance n'est pas, comme Maslow l'a suggéré, une préoccupation qui émerge lorsque tous les besoins d'ordre inférieur (ou plus fondamentaux) sont assouvis. Au contraire, c'est chaque fois que la personne complète une boucle du processus qu'elle se développe. En effet, chaque fois qu'elle traverse toutes les étapes du déroulement d'une expérience, elle assume et intègre cette dernière et devient, de ce fait, riche de cette nouvelle expérience. Le changement n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais la personne peut le reconnaître à partir du sentiment d'unification qu'elle éprouve à ce moment-là . Ce n'est que lorsque la personne réussit à s'assumer dans quelque chose de relativement spectaculaire que le changement est facilement visible de l'extérieur. Par exemple, lorsqu'elle réussit, pour la première fois, à donner son avis à une figure d'autorité, lorsqu'elle ose enfin exposer ses toiles, etc.

La croissance est le résultat d'une adaptation continuelle aux défis que pose la vie et à ceux qui émergent sous forme d'aspirations. Plusieurs fois par jour, la vie présente des défis qui prennent la

forme d'aspirations, de désirs ou de problèmes : un rapport à produire, un problème avec le patron, le désir dans une relation, une nouvelle habileté à maîtriser... Chaque fois que la personne parvient à se respecter et s'assumer totalement dans un de ces défis, elle a une impression d'accomplissement, le sentiment d'être plus complète. Mais lorsqu'elle évite de confronter des défis importants pour elle, c'est l'immobilité qui la guette; elle a l'impression, à juste titre, de ne pas évoluer ou même de se dégrader.

2- La hiérarchie des besoins revue

Au risque de scandaliser les disciples de Maslow, nous devons également dire que l'échelle de besoins qu'il nous a présentée n'a plus sa place dans notre vision des priorités qui motivent l'être humain. Cette fois, ce n'est pas l'observation du processus de développement de l'expérience qui nous mène à cette conclusion, mais plutôt nos observations sur le phénomène du transfert.

Nous avons maintenant la conviction que la recherche de la liberté intérieure (liberté d'être soi-même) est une des forces dominantes chez l'être humain. Sa tendance actualisante, ou force de vie, le pousse sans cesse à rechercher et à s'investir avec personnes et dans des situations qui sont significatives pour lui. Sans qu'il en soit nécessairement conscient, ces investissements s'avèrent des occasion d'évoluer. L'une ou l'autre des problématiques transférentielles, "droit à l'existence", "droit à une identité distincte" et "droit d'être sexué" (Garneau, Larivey 1978,1983) sont en effet toujours en jeu dans ses relations importantes. Nous en sommes venus à penser que la tendance actualisante poussait continuellement l'individu à résoudre ses transferts. Il le fait pour reprendre possession du pouvoir qu'il cède encore aux figures significatives de son enfance (Larivey 1999).

La manière dont la personne voit à ses besoins physiques, de sécurité, d'affection (pour reprendre les catégories de Maslow) est tributaire de sa problématique transférentielle actuelle. Celle qui lutte pour obtenir plus de sécurité au travail, par exemple, entreprendra sa démarche différemment selon qu'elle a ou non acquis le "droit d'être comme personne". De plus, son défi, au-delà de ses objectifs de sécurité, sera lié à sa problématique transférentielle.

3- Adaptation au sens de synthèse organismique

Il est important de préciser le sens exact de l'*adaptation* qui permet la croissance. Il ne s'agit certes pas de la forme d'accommodation où la personne se conforme à ce que l'environnement attend d'elle. L'adaptation dont il est question ici est plutôt *un changement que produit la personne en choisissant d'agir d'une manière qui tient compte de tout ce qui lui importe (particulièrement de ses besoins et de ses valeurs) tout en prenant en considération les exigences de la situation.* En d'autres termes, elle se respecte totalement en tenant compte des circonstances. Le changement est donc le produit d'une **synthèse** de son expérience et des exigences extérieures : la meilleure synthèse qu'elle peut

réussir à ce moment particulier de son évolution. On pourrait comparer cette adaptation-croissance aux mutations que réalisent les végétaux pour devenir plus aptes à résister aux dangers de leur milieu. Le cactus s'est muni d'aiguilles pour se protéger des animaux qui voudraient profiter de sa capacité de garder son humidité; on ne peut considérer cette évolution comme une adaptation qui le diminue. Au contraire, il faut parler de "valeur ajoutée" à son identité de cactacée.

Pour qu'un changement d'une telle qualité puisse avoir lieu chez l'humain, il faut que son expérience soit traitée correctement. Le fait de respecter ou faciliter le "processus vital d'adaptation" garantit cette qualité. La personne qui s'abandonne au contenu de son expérience à travers les différentes étapes (émergence, immersion, développement, prise de signification et action unifiante), choisit en effet de s'en remettre à l'ensemble de son organisme pour traiter son expérience. L'auto-régulation qui en résulte grâce à l'action unifiante contribue à son développement.

En accordant autant d'importance à la régulation organismique et au rôle du *processus vital d'adaptation* pour traiter l'expérience émotive, il nous fallait, comme psychothérapeutes, une compréhension approfondie des phénomènes émotionnels. C'est en effet à travers des préoccupations toujours accompagnées d'émotions que la *tendance actualisante* se manifeste. Il nous a donc fallu clarifier la nature et la fonction des divers phénomènes émotifs.

III. Une théorie des émotions

C'est à cause de notre travail clinique que nous avons eu besoin de clarifier les phénomènes émotifs. Nous avons vite constaté que les théories sur les émotions développées en recherche fondamentale ne nous étaient d'aucune utilité réelle. Elles ne l'étaient pas davantage pour nos clients dont notre approche exige qu'ils deviennent habiles à identifier correctement et précisément ce qu'ils vivent. Quant aux théories des émotions conçues dans d'autres courants thérapeutiques, comme celle de l'approche émotivo-rationnelle, elles ne correspondent pas suffisamment à notre compréhension de la vie psychique pour nous convenir. C'est donc à travers l'observations de nos clients, notre expérience personnelle, nos lectures ainsi que de multiples discussions entre collègues que nous en sommes venus à articuler une conception de la vie émotive qui soit réellement utile au thérapeute et au client en Auto-développement.

A- Une conception des émotions

1- L'émotion au coeur du processus vital d'adaptation

Le *processus vital d'adaptation* est "l'épine dorsale" du travail thérapeutique tel qu'il se fait dans notre approche. D'une part, le thérapeute agit comme facilitateur pour que le contenu traité en

entrevue se déroule selon ce processus et d'autre part, il poursuit l'objectif de rendre le client autonome par rapport à ce processus. Or, l'émotion est au coeur de celui-ci (Garneau, Larivey 1979-1983, chapitre 2). L'*émergence* prend toujours la forme d'une émotion ou d'une préoccupation accompagnée d'une émotion. L'*immersion* consiste à ressentir complètement l'émotion. La recherche active faite à l'étape du *développement* s'appuie en large partie sur les émotions. La *prise de signification* est toujours chargée d'émotion. L'*action unifiante* prend généralement la forme d'une expression émotive. Enfin, pour que son action soit assumée, la personne doit nécessairement se laisser atteindre par les effets de son action, donc ressentir. Il est donc devenu impératif, d'appliquer une certaine rigueur à cette vie émotionnelle dont le fonctionnement et l'organisation apparaissent souvent insaisissables, au profane, voire au psychothérapeute.

2- La fonction de l'émotion

La vie émotionnelle a une fonction équivalente à celle de la vie sensorielle. Elle fait partie d'un système d'information qui participe à l'auto-régulation organismique. *L'émotion informe sur l'effet que produit sur la personne sa réalité externe ou interne.* Les personnes et les événements ont un impact sur elle et c'est par l'émotion que ceux-ci suscitent qu'elle appréhende la nature et l'ampleur de cet impact. Il est également possible de déclencher des émotions par la pensée ou l'imagination. Dans ces cas encore, elles révèlent l'impact sur la personne elle-même de sa pensée, son souvenir ou la production de son imagination.

Le fait de pouvoir ressentir donne à l'humain une sorte de contact avec la vie : c'est par l'émotion qu'il se sent vivre! Mais il y a plus : les émotions sont essentielles à sa survie et à son bien-être. Autant les sensations sont indispensables à l'humain pour maintenir son équilibre et son bien-être physique, autant les émotions sont l'instrument nécessaire de sa capacité de veiller à sa survie. Les personnes qui sont coupées de leur vie émotive ne sont plus capables d'assurer leur subsistance et doivent être prises en charge par leur environnement. De même, celles dont la vie émotive est substantiellement atrophiée par des drogues, ne sont plus capables d'assumer la responsabilité de leur vie.

Sur le plan des échanges, l'information que procurent les émotions permet de communiquer en traduisant l'importance de ce qui est vécu. Les échanges entre humains n'auraient pas le même potentiel énergétique s'ils étaient complètement dénudés d'affect. Les relations privées d'émotion et les échanges qui ne comportent pas de charge émotionnelle sont typiquement peu nourrissants.

L'humain dispose d'un système émotionnel d'une grande finesse. L'éventail des émotions est large et chacune correspond à des particularités et à des nuances de l'expérience. Le raffinement et la variété de l'expérience humaine s'appuie sur ce vaste répertoire de symboles; c'est ce qui permet à la personne d'identifier avec une grande précision la façon dont elle est affectée dans ses contacts de même que de choisir des actions qui l'expriment avec un grand raffinement.

Dans l'inventaire de ce que l'on considère généralement comme des émotions on trouve toutefois un grand nombre d'expériences apparemment émotives mais qui ne sont pas des émotions à proprement parler. La précision exigée par le *processus vital d'adaptation* nous a obligés à distinguer les émotions réelles de celles qui n'en sont pas. L'exercice s'est avéré très intéressant et surtout, très utile.

Il nous a conduit à construire une typologie ainsi qu'a préciser le genre d'information que contient chaque expérience émotionnelle. En ce qui concerne les émotions simples, le seul fait de les ressentir et de leur permettre de se dérouler selon le processus vital d'adaptation, conduit naturellement à une compréhension de ce qui se passe, puis au choix de l'action appropriée pour en tenir compte. En ce qui concerne les expériences émotionnelles mixtes ou celles qui ne sont pas des émotions, il n'est pas aussi simple d'en tirer l'information utile. Selon te type d'expérience, la façon de s'en servir varie et nous avons dû apporter ces précisions pour chacun. Une première version de cette synthèse est disponible depuis plusieurs années pour les psychothérapeutes auxquels nous donnons de la formation (Larivey 1978), mais ce n'est que tout récemment qu'elle est devenue publique sous une forme accessible à tous (Larivey 1998).

B- Une typologie des phénomènes émotifs

La typologie que nous avons élaborée comprend quatre groupes. Les émotions simples, les émotions mixtes, les phénomènes émotifs provenant des émotions repoussées et finalement, les pseudo-émotions. Nous continuons de raffiner ces catégories en prévision d'une publication prochaine à l'intention du grand public. Voici un aperçu de cette conception.

1. Les émotions simples

En tant qu'éléments issus du système d'information, les émotions renseignent sur les besoins. L'émotion étant vécue dans le présent, les émotions informent sur le degré de satisfaction de besoins présents.

Les émotions simples se divisent en deux grandes catégories : les émotions marquant la **satisfaction** et celles indiquant l'**insatisfaction**. Les émotions de satisfaction sont habituellement considérées comme positives alors que celles qui indiquent l'insatisfaction sont jugées négatives. En tant que porteuses de messages concernant les besoins, toutefois, les émotions sont toutes positives, même celles qui sont désagréables.

Chacun de ces deux sous-groupes se divise en trois sections : les **émotions d'anticipation**, les **émotions par rapport à l'objet de satisfaction** et les **émotions en rapport avec la source ou l'obstacle à la satisfaction**. Ces distinctions peuvent apparaître superflues, mais elles procurent des

précisions importantes quant au traitement qu'on doit faire de ces diverses expériences. Par exemple, il est très utile au thérapeute de comprendre qu'une personne s'en prend toujours aux obstacles et perd de vue son besoin lorsqu'elle est frustrée. De même, en sachant qu'une émotion donnée est suscitée par une anticipation il peut la traiter autrement qu'une émotion qui s'adresse directement à une réalité présente.

Tout comme le thérapeute, le client qui connaît ces distinctions est en mesure de mieux se servir de ces expériences. Il peut choisir des actions plus appropriées pour combler ses besoins.

2. Les émotions mixtes

Parfois, comme dans le cas de la jalousie, elles se composent de plusieurs émotions simples. Dans d'autres cas, comme la culpabilité, elles comprennent une émotion et des composantes d'un autre ordre. Il est nécessaire de démêler les composantes des expériences émotionnelles mixtes car ce n'est qu'en comprenant bien ce qu'elles sous-tendent qu'on peut les traiter adéquatement. Il serait néfaste, par exemple, de tenter de ressentir un vécu composite comme la culpabilité et on se retrouverait bientôt dans une impasse.

3. Phénomènes émotifs résultant d'émotions repoussées

Dans cette catégorie on rencontre diverses expériences comme le malaise, l'angoisse, le vide. Le fait de bien connaître la nature de ces expériences permet au thérapeute et au client de s'engager dans des voies efficaces. Il ne servirait à rien de "ressentir" l'angoisse, par exemple, cela ne pourrait mener qu'à une plus grande angoisse. Il faut plutôt chercher à identifier l'évitement qui conduit à cette angoisse si on veut s'attaquer à ce qui permettra la disparition de l'angoisse.

4. Pseudo-émotions

Nous avons regroupé dans cette catégorie diverses expériences dont on parle généralement comme s'il s'agissait d'émotions, même si elles n'en sont pas. On y trouve des **images** (je me sens écrasé, grand); des **actions** posées par d'autres (je me sens rejeté, rabaissé); des **états** (je me sens serein, calme); des attitudes, des évaluations, etc. Souvent ces expressions sont utilisées pour tenter de cerner le vécu. En sachant qu'elles ne sont pas des émotions réelles, on peut les considérer comme une approximation de l'émotion, comme un point de départ pour cerner l'émotion. C'est encore le processus qui nous a obligés à ces précisions. Par exemple : il est impossible d'éprouver directement "le sentiment d'être rejeté" mais le fait de se croire rejeté suscite différentes émotions (peine, colère, déception...) qu'il est possible de ressentir.

En somme, la théorie sur les émotions, comme son arrimage à la conception du vivant, constitue une dimensions précieuse de l'instrumentation du client. Nous en sommes particulièrement satisfaits parce qu'elle s'inscrit dans un vide déplorable: celui de l'éducation à la vie émotive. Comme ils disposent de peu d'information et de formation à ce sujet, la famille et l'école en sont réduites à perpétuer une éducation inadéquate à la vie émotive. Les spécialistes du psychisme, particulièrement les psychothérapeutes, ont un grand rôle à jouer dans ce domaine.

IV. La résolution du transfert

Notre compréhension des éléments qui permettent la résolution du transfert fut la première à subir une transformation majeure après 1979. La vision nouvelle qui en est issue nous a amenés à comprendre de nouvelles dimensions essentielles du changement personnel et de la croissance.

A- Les acquis antérieurs

Nous avions déjà souligné comment notre expérience de psychothérapeutes humanistes nous a forcés à reconnaître l'importance du transfert malgré le fait que notre orientation nous invitait à y voir plutôt un effet d'une forme particulière d'intervention : la psychanalyse. Nous avions déjà reconnu que les expériences transférentielles de nos clients s'articulaient autour de trois problématiques de développement personnel : le *droit à l'existence*, le *droit à une identité distincte* et le *droit à une identité sexuelle*. Nous avions déjà constaté que ces expériences étaient reliées au développement personnel et que nous pouvions aspirer, contrairement à ce qu'on disait dans le courant psychodynamique, à un travail de résolution qui débouche sur une meilleure intégration de la personne. Nous savions déjà que c'était dans une relation intensément chargée avec un interlocuteur transférentiel que la résolution était possible, grâce à une expression ouverte accompagnée de la conscience de la nature transférentielle de la relation.

B- L'insight nouveau

Ce que nous n'avions pas encore compris, c'est la place déterminante de l'expression bien assumée. Nous pensions alors que la résolution du transfert équivalait en quelque sorte à une expérience de rééducation à travers une contact nouveau. L'attitude et la réponse de la personne transférée nous semblait alors tout aussi déterminante que la qualité de l'expression de la personne qui l'investit d'une importance transférentielle. Le comportement de l'interlocuteur était à nos yeux l'équivalent de celui d'un éducateur qui crée une situation pédagogique permettant de corriger un ancien apprentissage erroné. Nous insistions donc sur les caractéristiques de la réponse thérapeutique adéquate et sur la satisfaction suffisante des besoins caractéristiques de chaque niveau de transfert.

Encore une fois, ce sont nos clients qui nous ont forcés à réviser notre conception. Nous avons dû constater par l'expérience que le type particulier de changement que permet la résolution du transfert survenait quand-même dans des situations où la réponse de l'interlocuteur transféré (ou du parent réel) était loin de nous apparaître adéquate. C'est alors que nous avons commencé à croire que les enjeux n'était pas essentiellement des besoins fondamentaux à satisfaire, mais bien des libertés personnelles à conquérir.

Ce que nous avons constaté, c'est que la qualité du résultat dépendait entièrement de la qualité de l'expression faite par le client et nullement de la réponse de l'interlocuteur transféré. C'est alors que nous avons compris que *le changement obtenu découlait directement du fait que la personne assumait entièrement son expérience en contact avec la figure parentale.* On peut donc récupérer son pouvoir sur une dimension aliénée de sa vie si on trouve le moyen de lui faire ouvertement la place qui lui revient dans un contact direct avec la personne devant laquelle on l'avait reniée. On peut y parvenir également si on le fait avec un équivalent subjectif (interlocuteur transférentiel), peu importe que cette action expressive se déroule avec un thérapeute ou non. En somme, c'est en osant changer devant les personnes qui ont de l'importance à ses yeux que la personne parvient à se développer. Les autres étapes de sa démarche sont également nécessaires, mais il s'agit d'une préparation. C'est à "l'action unifiante", par l'expression entièrement assumée, que se fait le changement lui-même.

Cette découverte apparemment un peu simpliste a entraîné toute une série de conséquences sur notre compréhension du développement personnel et du cheminement thérapeutique. Elle a d'abord confirmé et précisé la place de "l'action unifiante" dans le "processus vital d'adaptation". Celle-ci est non seulement la cause directe du changement, elle est le moment de changement, elle est le changement lui-même. C'est le moment où la personne choisit d'assumer ce qu'elle est et, par conséquent, d'en prendre possession et de s'unifier elle-même.

Cette compréhension plus précise des conditions réelles de la résolution du transfert nous a également amenés à voir celui-ci non pas comme la tentative d'obtenir un degré adéquat de satisfaction d'un besoin fondamental, mais comme l'effort spontané de la personne et de tout son organisme pour *reprendre possession de dimensions importantes de son identité et de son expérience intérieure*. Le transfert devient dès lors un mouvement de croissance personnelle, *un élan vers l'actualisation*. Il correspond à la manifestation la plus pure de la tendance actualisante en fournissant à la démarche de développement personnel son orientation et sa finalité.

Nous étions déjà sensibles au fait qu'il ne fallait pas, dans la réponse, devancer, pour répondre au besoin, le moment de l'expression complète où la personne s'assume entièrement avec son besoin et son expérience subjective. Il restait encore à découvrir que l'absence de réponse, quoique pénible, n'enlevait pas à la personne le bénéfice de son expression complète. C'est d'abord de façon accidentelle, dans des situations dont le déroulement ne dépendait pas de nous, que nous avons eu accès à ces résultats inattendus. Mais une fois le premier étonnement passé et lorsque nos hypothèses

de travail se sont ajustées à ces faits nouveaux, nous avons vite constaté que ces "résultats accidentels" correspondaient à la situation la plus fréquente hors du contexte thérapeutique.

C- Le transfert actif: un axe de croissance

Notre vision du transfert s'est également transformée à cette occasion. Une observation plus minutieuse nous a permis de constater que chaque personne, à un moment particulier de sa vie, est occupée à la résolution d'un type particulier de transfert. Que ce soit avec succès ou dans des échecs répétés, elle s'investit intensément dans diverses relations transférentielles qui se ressemblent entre elles. Les personnes qui sont pour elle les plus importantes (au plan émotif) à cette époque de son cheminement correspondent donc à une problématique transférentielle homogène. C'est ce que nous appelons un axe de croissance.

Avec la répétition, nous en sommes venus à conclure que le transfert, dans ses manifestations multiples qu'on rencontre au coeur de la vie de tous les jours, est la principale force de croissance qui anime l'organisme, au moins du point de vue de sa tentative générale d'élargir l'éventail de ses possibilités et d'étendre le territoire psychologique qu'elle est capable de vivre et d'assumer.

Les choses se passent comme si la personne cherchait à récupérer une dimension de son existence à laquelle elle avait renoncé dans sa relation avec les personnes les plus significatives de son enfance. Elle s'est reniée dans l'espoir d'obtenir ou de conserver leur amour; elle se replonge sans cesse dans le même dilemme afin de parvenir à une solution plus harmonieuse et plus satisfaisante. Tant que le succès lui échappe, elle recrée des situations du même genre, comme pour essayer à nouveau de relever adéquatement le défi. Mais dès qu'elle parvient à se respecter vraiment devant les personnes importantes dans cette dimension de son expérience, elle semble passer rapidement à un autre défi. Ses relations importantes changent et les interlocuteurs qui ne suivent pas cette évolution sont bientôt relégués au rang de relations secondaires ou de "bons souvenirs".

Cette vision des choses fait du transfert une dimension importante de la compréhension de la position psychologique de la personne à un moment particulier : elle nous oblige à intégrer dans notre diagnostic une évaluation du "transfert actif". Mais c'est une position très particulière et privilégiée qu'occupe le transfert dans le tableau diagnostic : il nous indique dans quelle direction et sur quel défi les forces de croissances sont principalement actives. Autrement, dit, le transfert nous permet de connaître **sur quelle capacité psychologique porte l'effort organismique de croissance** et, par conséquent, ce que notre intervention devra supporter.

Pour mieux comprendre l'importance de cette conclusion, une vision d'ensemble de cette méthode particulière de diagnostic psychologique est nécessaire. C'est en effet dans le contexte de ce diagnostic à trois volets qu'il prend toute sa signification.

V. Un psychodiagnostic humaniste

Tous les éléments nécessaires étaient déjà présents dans notre synthèse de 1979. Les trois volets étaient déjà clairement formulés. Nous avions soigneusement décrit un "processus naturel de croissance" circulaire en six étapes, ainsi que ses dysfonctions les plus fréquentes. Nous avions jeté les bases essentielles d'une conception du transfert comme phénomène omniprésent dans les situations de la vie courante et comme lieu crucial de développement personnel, avec ses trois types généraux qui correspondent à des préoccupations particulières du point de vue de la capacité de vivre son expérience et de s'assumer. Nous avions soigneusement défini quatre défis existentiels fondamentaux en précisant plusieurs de leurs liens avec les dimensions caractérielles du fonctionnement de la personne.

Plus encore, nous avions déjà identifié l'importance d'évaluer le fonctionnement du processus pour orienter l'intervention en Auto-développement. Il s'agissait alors d'une cible de choix du point de vue de l'instrumentation. À l'époque, nous misions beaucoup sur un instrument de mesure auquel travaillait notre collègue Ernest Godin (1975), le "Test du processus de croissance (TPC)". Les recherches étaient encourageantes et nous espérions disposer bientôt d'un outil précieux d'évaluation du fonctionnement de la personne du point de vue de sa façon de traiter son expérience. Il était déjà évident qu'une telle évaluation pouvait être un instrument précieux pour guider le travail du thérapeute en lui indiquant les cibles d'intervention et d'instrumentation à privilégier.

Le TPC ne s'est pas montré à la hauteur de nos espoirs. Il permettait une évaluation valide du fonctionnement du processus chez les individus; les thérapeutes experts le confirmaient de même que les principaux intéressés, les clients. Malheureusement, sa correction s'est avérée beaucoup trop onéreuse pour en faire un instrument commode comme nous l'avions espéré. Il fallait former longuement les personnes pour les rendre capables de le corriger adéquatement et il fallait que ces juges compétents y consacrent un temps assez important. Nous avons dû en venir à la conclusion que ce processus était mesurable, mais que l'outil dont nous disposions ne pouvait raisonnablement être utilisé dans un contexte clinique. Il valait donc mieux utiliser l'habileté du psychothérapeute pour en arriver rapidement à un diagnostic fiable. Cet obstacle majeur est alors devenu un tremplin qui nous a permis des progrès importants.

L'expérience prise au cours de l'expérimentation du TPC nous avait permis de maîtriser un peu le diagnostic clinique du processus. Le fait de cesser de compter sur cet instrument "objectif" nous a donné l'occasion d'exploiter cette maîtrise acquise à force de réflexion et de discussions. En fait, il nous apparaissait relativement facile de faire un tel diagnostic pour chacun de nos clients. De plus, les professionnels qui faisaient appel à nous pour leur formation réclamaient des balises pour les guider dans le choix des instruments à transmettre à leurs clients, conformément aux exigences de l'Auto-développement. Libérés des exigences artificielles de la démarche de validation d'un test, il est devenu tout naturel de répondre à ces attentes de nos stagiaires en leur transmettant nos façons de procéder. C'est également cette liberté nouvelle qui nous a permis d'intégrer les deux autres

dimensions de notre méthode d'évaluation psychologique : **le niveau de transfert actif et le déni existentiel unificateur**.

A- Un diagnostic en trois volets

Cette méthode diagnostique s'appuie sur trois dimensions complémentaires du fonctionnement de la personne. Il s'agit en fait de trois axes dont la combinaison nous donne une vision relativement complète du fonctionnement de la personne, du point de vue des objectifs de l'intervention thérapeutique.

L'examen du processus nous renseigne sur **les mécanismes de traitement de son expérience** qui sont disponibles. Il informe donc le psychothérapeute sur les habiletés à développer dans une stratégie d'instrumentation. C'est la base de l'acquisition d'habiletés qui est au coeur de l'autonomie que le client développera par rapport à la thérapie.

Les deux autres dimensions concernent **le contenu des conflits psychiques** à considérer. Le volet transférentiel porte sur l'effort de croissance qui est en cours alors que le volet existentiel permet de comprendre les principales forces qui s'opposent à cette croissance, les dénis autour desquels la personnalité s'organise dans un effort d'adaptation rigide.

Le volet du transfert a donc une place centrale dans toute démarche de psychothérapie; c'est à travers les expériences qui le composent et la résolution des conflits psychiques qui lui donnent son orientation que le changement important du fonctionnement de la personne peut se faire. C'est en vertu du travail de résolution fait à ce niveau qu'on peut parler d'une forme de psychothérapie dont le but est de "changer vraiment" la vie de la personne.

Quant au volet existentiel, il permet surtout de comprendre les dimension "caractérielles" du fonctionnement de la personne. C'est en effet autour d'un déni existentiel principal que s'organise l'ensemble de la structure de la vie de chaque personne. Toute démarche de croissance doit en tenir compte et un grand nombre de situations de crise majeure en découlent. Le thérapeute qui n'en tiendrait pas compte serait un peu aveugle et souvent incapable de comprendre pourquoi le changement espéré ne survient pas.

1- Le volet du processus

Le premier axe est celui du processus. Il nous permet d'évaluer les mécanismes psychiques dont dispose la personne pour traiter son expérience et, par conséquent, s'adapter à sa réalité intérieure et au contexte dans lequel elle se trouve (sa réalité extérieure). Ce sont donc les habiletés dont dispose la personne qui sont examinées et évaluées. Cette dimension de l'évaluation psychologique

nous indique quelles sont les habiletés qui devront devenir des cibles d'instrumentation.

La façon de procéder est relativement simple pour un professionnel qui est bien familier avec le processus tel que nous l'avons décrit (Garneau et Larivey, 1979). Il s'agit d'évaluer le fonctionnement actuel de la personne du point de vue de chacune des six étapes du processus afin d'identifier si les activités caractéristiques de chacune sont sur-utilisées, sous-utilisées ou adéquatement utilisées.

Les activités sur-utilisées correspondent à ce qu'on pourrait appeler des mécanismes de défense : il s'agit de comportements psychiques qui sont normalement utiles mais qui ont, chez cette personne, une fonction défensive ou d'évitement. En plus de servir aux moments où elles sont appropriées, ces façons d'agir apparaissent à des moments où, selon la dynamique interne du processus, elles sont inappropriées. L'exemple le plus simple est celui de "l'action unifiante" intempestive qui survient au moment où "l'émergence" serait normale. Devant l'inconfort typique de la pré-émergence", la personne se met en action plutôt que de laisser "l'émergence" se faire naturellement. L'action, n'étant pas appuyée sur le cheminement à travers les diverses étapes qui la rendraient significative, ne peut être "unifiante". Elle n'est que défensive.

Les activités sous-utilisées sont, bien sûr, celles qui sont remplacées par les activités sur-utilisées. Elles correspondent à des habiletés sous-développées dont devra se charger l'instrumentation systématique caractéristique de l'Auto-développement. Ces étapes du processus deviennent donc des cibles directes de l'intervention du thérapeute qui doit évidemment tenir compte du lien entre l'activité sous-utilisée et l'activité sur-utilisée qui la remplace.

2- Le volet du transfert

La particularité la plus intéressante du diagnostic transférentiel est de porter sur **l'effort de croissance qui est en cours** chez la personne, du point de vue du contenu des conflits psychiques à résoudre. C'est donc en quelque sorte la tendance actualisante en action que nous examinons dans cette dimension du diagnostic, sous l'angle du contenu et non du processus.

Il faut comprendre que, selon notre conception, le transfert est moins une répétition compulsive d'un conflit qu'une tentative obstinée de le résoudre. La personne crée, plus ou moins inconsciemment, des situations qui lui posent les mêmes défis qu'une situation de son enfance. Plus précisément, c'est des dimensions où sa solution avait consisté à se renier qu'elle s'occupe en recherchant des situations interpersonnelles analogues. Le but de cette répétition est de trouver une nouvelle adaptation où *elle ne reniera rien* de son expérience réelle; une façon de faire face au défi en se respectant entièrement. Lorsque ce défi est relevé avec succès, c'est une liberté et un pouvoir nouveaux que la personne obtient : elle est capable de porter ouvertement ses besoins auxquels elle avait autrefois tenté de renoncer et de trouver dans sa vie de tous les jours les moyens de les satisfaire.

Lorsque nous faisons le diagnostic transférentiel, nous cherchons à identifier à quel défi de ce genre la personne est occupée. Il s'agit de déceler la fonction de l'ensemble des relations les plus importantes, au plan affectif, du point de vue des types de besoins transférentiels. Nous avons constaté en effet que chaque personne est relativement unifiée à cet égard. À chaque époque de sa vie, elle est occupée à trouver la solution à un seul dilemme transférentiel. Elle le fait dans l'ensemble de sa vie, dans toutes ses relations où il y a une charge émotive. Lorsqu'elle parvient à une solution, cette cible de travail est remplacée par une autre (également transférentielle) et l'univers relationnel de la personne change de façon importante. Les personnes auparavant les plus importantes verront leur place redéfinie, au point même de disparaître progressivement de la vie de la personne. D'autres deviennent importantes parce qu'elles sont transférentiellement investies dans la recherche de satisfaction d'un autre besoin.

Nous cherchons donc "à quel niveau de transfert" se trouve la personne à ce moment de sa vie ou, autrement dit, auquel des trois types de besoins transférentiels elle est actuellement occupée, dans l'ensemble de sa vie. Ce qui se passe par rapport au thérapeute est évidemment une source précieuse d'information, mais les découvertes qu'on fait à travers cette situation doivent être validées par un examen des autres relations émotivement chargées de cette personne. Toute contradiction apparente entre ces deux univers nous avertit que notre compréhension est encore insuffisante. C'est un effort unifié de croissance que nous cherchons à identifier : un mouvement de fond de l'organisme dans son ensemble, poussé par la tendance actualisante elle-même.

Bien sûr, il ne suffit pas d'identifier simplement un "niveau" de transfert. Cette première conclusion doit être raffinée par des précisions qui cernent plus exactement les enjeux et le jeu de forces en cours pour cette personne, à ce moment. Mais le fait d'identifier le niveau actif est un premier pas nécessaire : il permet de cerner une cible générale unique (droit à l'existence, à une identité distincte ou à une identité sexuelle) à l'intérieur de laquelle les diverses précisions viendront s'insérer. Tant que nous n'avons pas identifié ce pôle autour duquel s'articule la cohérence interne de l'effort de croissance, nous n'avons pas les éléments nécessaires à une véritable compréhension du cheminement de la personne.

En fait, la connaissance des enjeux transférentiels permet au thérapeute de comprendre bien plus que l'ensemble des événements importants de la relation thérapeutique. Elle lui fournit une grille pour interpréter toutes les relations interpersonnelles significatives de son client. Avec le temps, nous en sommes même venus à croire que fondamentalement, tout le contenu des préoccupations du client (les sujets qu'il aborde ou évite en thérapie) est d'ordre transférentiel ou existentiel. Ces deux dimensions permettent de comprendre les enjeux réels de chaque préoccupation immédiate.

En plus de permettre cette compréhension générale, le diagnostic du transfert permet au thérapeute de mieux jouer son **rôle d'interlocuteur objet de transfert**. Connaissant à l'avance la nature des enjeux réels et leur importance, il lui est plus facile d'intervenir de façon pertinente et de voir les pièges que lui tend plus ou moins consciemment le client. De cette façon, il lui est plus facile de

favoriser une résolution réelle par le client et de prévenir l'interférence de ses propres contre-transferts.

3- Le volet existentiel

Comme nous l'avons souligné plus haut, cette partie du diagnostic sert également à comprendre le contenu des préoccupations du client. Mais c'est par la négative qu'elle nous procure cette compréhension. En effet, ce volet du diagnostic consiste à identifier le déni existentiel principal autour duquel s'est organisée la vie du client, dans ses dimensions défensives ou caractérielles. C'est donc l'absence apparente d'une préoccupation qu'il s'agit d'identifier.

Nous avions déjà décrit, en 1979, quatre défis existentiels fondamentaux chez les humains et nous avions évoqué leur importance dans la compréhension des problèmes psychologiques. Ces quatre réalités inhérentes à l'existence sont **la mort, la solitude, la liberté et la finitude**. Elles apparaissent *a priori* comme des impasses angoissantes qu'il est impossible d'accepter. Elles sont en réalité des aspects fondamentaux de la vie humaine dont la confrontation et l'acceptation sont les aboutissements principaux du cheminement naturel de croissance chez chaque individu. Le fait de refuser cette confrontation en niant le défi existentiel correspondant est lourd de conséquence : il détermine l'organisation d'ensemble de la vie de la personne, dans ses aspects statiques et compulsifs. L'ensemble des symptômes se met en quelque sorte au service de ce déni, condamnant par le fait-même la personne à une insécurité permanente qui ne peut trouver sa solution qu'à travers une confrontation existentielle complète.

Parce que son but est d'identifier un déni, c'est à dire le refus et l'absence apparente d'une réalité, le diagnostic existentiel est le plus difficile à faire. Il s'agit d'identifier quelque chose qui est refusé au point d'être systématiquement absent des préoccupations et de la vie de la personne. Par exemple, la personne qui fait un déni de la mort n'est pas celle qui se préoccupe de sa mort ou de celle de ses proches, mais celle qui ignore cet aspect de l'existence au point de ne plus accorder d'importance réelle à la vie.

C'est donc en comparant le fonctionnement de la personne avec une grille théorique des défis existentiels fondamentaux que nous parvenons à identifier cet élément absent qui nous indique quel est le déni autour duquel s'organise la vie de la personne. Plus précisément, nous cherchons à identifier la réalité que la personne conteste avec le plus de vigueur, non seulement en paroles, mais également dans des actes et même dans l'organisation d'ensemble de sa vie. On pourrait dire aussi qu'il s'agit de la réalité contre laquelle la personne se mobiliserait ou protesterait avec le plus de vigueur si elle s'y trouvait soudain confrontée (comme c'est souvent le cas dans ce qu'on appelle une *crise existentielle*).

Bugental (1965) disait qu'on peut voir au centre de toute névrose un ou plusieurs problèmes

existentiels qui lui donnent son sens. Après une vingtaine d'années de diagnostic systématique des dénis existentiels chez nos clients et ceux des professionnels que nous formons ou supervisons, il nous semble que c'est autour d'un seul déni que s'organise le système psychique d'une personne, même lorsqu'elle n'a pas confronté plusieurs des réalités existentielles que nous avons identifiées. Que plusieurs dénis soient présents en même temps importe peu, ce que nous croyons utile d'identifier, c'est le défi existentiel autour duquel s'organise la personnalité. Nous croyons qu'il est plus important pour guider nos interventions d'identifier ce pôle défensif intégrateur que de faire un inventaire complet des réalités existentielles que la personne accepte ou refuse.

Le volet existentiel du diagnostic a une utilité bien particulière qui en fait vraiment le complément des deux autres. Contrairement au diagnostic du transfert qui nous permet de prévoir les efforts les plus importants du client dans sa démarche de croissance, celui-ci nous avertit des impasses les plus probables. Ce sont les forces opposées au changement et à l'adaptation qui se trouvent réunies autour du déni existentiel. Il n'est pas étonnant, si on comprend bien ce fait, d'y trouver l'explication d'un grand nombre d'échecs thérapeutiques et de thérapies qui stagnent.

Les dénis sont en effet tellement massifs qu'ils constituent une cible de confrontation tentante pour tout thérapeute qui ne partage pas le même déni. La confrontation intempestive qui s'offre au professionnel est vouée à l'échec. Elle attaque le coeur-même de l'organisation caractérielle du client et constitue de ce fait une menace considérable qui ne peut que mobiliser tout le système défensif. On en vient rapidement à une position polarisée : le thérapeute insiste sur un point qui lui apparaît comme un défaut évident de fonctionnement qu'il ne peut raisonnablement ignorer alors que le client, trop globalement menacé pour être ouvert et trop occupé à renforcer son déni pour se soucier d'autre chose, ne peut que demeurer sur ses positions. Seule une stratégie thérapeutique qui tient compte du déni et de son importance peut conduire à un changement sur ce point.

B- L'utilité particulière du diagnostic humaniste

C'est dans l'intervention thérapeutique que cette forme de diagnostic donne réellement ses fruits. Contrairement à la plupart des diagnostics psychologiques, celui-ci informe directement le thérapeute sur les objectifs exacts qu'il doit poursuivre dans son intervention.

Par le **volet du processus**, il lui signale quelles sont les habiletés qui manquent au client pour une gestion adéquate de son expérience vécue. Ces informations permettent de mettre en place une **instrumentation systématique** qui rendra le client capable de progresser par ses propres moyens.

Grâce au **volet du transfert**, le thérapeute connaît les principaux **enjeux de croissance** auxquels le client est sensible, non seulement dans la relation thérapeutique, mais également dans toutes ses relations psychologiquement importantes. Il peut ainsi comprendre les significations implicites d'un grand nombre d'événements précurseurs au travail explicite de résolution du transfert. Il peut, en

conséquence, éviter une multitude d'erreurs et augmenter considérablement l'efficacité de ses interventions.

Fort de la compréhension que lui procure le **diagnostic du déni existentiel**, le thérapeute peut éviter un grand nombre d'impasses en organisant sa stratégie pour que la **confrontation existentielle** se fasse de la façon la plus efficace. Il est capable d'éviter les confrontations intempestives et peut même identifier les dénis qui ressemblent au sien. Lorsque les situations de la vie provoquent une confrontation existentielle non planifiée, il est en mesure de comprendre ce qui se passe, d'en saisir les enjeux et d'adopter une façon d'intervenir qui permet au client de bénéficier de cette situation de crise.

En plus, par le travail de synthèse qu'il fait pour comprendre les interactions entre les trois volets de son diagnostic, le thérapeute est en mesure de comprendre le jeu de forces dans lequel il est appelé à intervenir. Il comprend comment le déni existentiel peut venir compliquer la résolution du transfert et comment la problématique transférentielle peut être maintenue par le fait que certaines habiletés de processus sont sous-développées ou sur-utilisées. C'est donc une compréhension unifiée et explicative du fonctionnement de son client que le professionnel obtient ainsi, une vision qui lui indique quels seront ses objectifs et ses cibles d'intervention.

Nous ne connaissons pas, en psychologie, d'autre système diagnostique qui fournisse autant de repères à l'intervention thérapeutique. Le diagnostic psychodynamique, par exemple, permet une compréhension explicative qui cerne les causes des problèmes, mais il n'a pas de conséquences directes sur la façon de résoudre ces derniers. Il peut tout au plus fournir des balises qui permettent au thérapeute de mieux comprendre les implications et les significations cachées des verbalisations et des actes du client. Les liens du diagnostic avec les particularités de l'intervention ont d'autres sources. Quant au système le plus généralement utilisé, le DSM, il permet d'obtenir un diagnostic descriptif qui s'inscrit dans un système de classification. Il ne fournit aucune information réelle sur les causes des problèmes psychologiques identifiés, ni sur leurs solutions. Il ne donne que des informations sur la fréquence d'apparition du problème, les circonstances où on l'observe et les autres troubles qui l'accompagnent. On s'en sert souvent pour indiquer, de façon trop globale pour être vraiment utile, quels est le taux de succès des divers traitements pour un trouble donné.

C'est pour cette raison que nous croyons que notre méthode de diagnostic peut constituer un apport important à la psychothérapie humaniste. À cause de ses origines où l'influence de Carl Rogers était une des forces dominantes, le courant humaniste a souvent été considéré comme refusant ou négligeant le diagnostic. Les méthodes les plus connues sont peu satisfaisantes pour un thérapeute humaniste parce qu'elle s'appuient sur des postulats contraires à ceux de son orientation. Elles manquent également de pertinence ou d'utilité réelle du point de vue de l'intervention. Nous croyons que la méthode que nous avons développée et utilisée depuis une vingtaine d'années peut combler ce vide.

VI. L'intervention à distance

Ce qui caractérise surtout l'Auto-développement, c'est son objectif stratégique fondamental : *transmettre au client les instruments nécessaires pour qu'il puisse diriger lui-même son cheminement de croissance à travers les situations normales de sa vie quotidienne*. Nous avons déjà approfondi les implications du concept d'instrumentation dans un article spécifique (Garneau 1984). Cette option fondamentale qui met l'accent sur l'instrumentation ne s'est jamais démentie, mais elle a pris des formes nouvelles. C'est dans l'intervention à distance qu'elle s'est surtout développée depuis 20 ans.

En 1979, il nous apparaissait déjà important de concrétiser notre option fondamentale d'instrumentation en explorant les possibilités de l'intervention où le thérapeute ne serait plus aussi nécessaire. Nous estimions possible de concrétiser nos choix les plus importants en transformant certaines de nos interventions en outils concrets auto-administrables. Ceci s'appliquait surtout aux interventions qui étaient de l'instrumentation directe. **L'hypothèse de travail** de cette démarche est la suivante : la méthode idéale pour transmettre au client les outils nécessaires à sa gestion de son propre développement est celle où le travail d'instrumentation serait fait par un enseignement que le client s'administrerait lui-même, à son rythme et à sa convenance, selon sa propre motivation.

A- Les programmes d'auto-développement

Un premier "programme d'auto-développement" était alors en pleine expérimentation et les résultats déjà disponibles s'avéraient prometteurs. Il semblait possible de préparer, sous une forme écrite, un programme composé d'activités d'apprentissage auto-administrables qui soit assez accessible pour s'adresser au grand public. La suite du projet nous a appris que les principaux défis de ce projet se trouvaient à d'autres niveaux.

Les recherches entreprises avec la collaboration de l'université Laval nous ont amenés à faire une programmation beaucoup plus complexe du cheminement afin de permettre à chaque individu de poursuivre une démarche unique, adaptée à sa motivation et aux résultats particuliers qu'il obtenait en cours de route. C'est vers un outil vraiment personnalisé que nous avons dû évoluer. La première conséquence directe de ce virage fut la nécessité d'élaborer considérablement le programme. En fait, son ampleur a dû tripler pour permettre cette individualisation nuancée et pour tenir compte de chacune des difficultés possibles que l'expérimentation nous avait permis d'identifier. Le programme "Savoir Ressentir" qui est actuellement offert au public ne correspond qu'au premier tiers de ce que prévoyait couvrir le programme. Les deux autres tiers sont dans un état de développement avancé; ils attendent notre touche finale pour être publiés.

Les recherches cliniques que nous avons faites depuis la publication du programme ont déjà été

présentées (Larivey et Garneau 1996)[1]. Elles confirment, dans des situations d'utilisation normales et par des clients réels, ce que nos recherches préliminaires nous permettaient de croire. Elles enrichissent également notre vision des possibilités de cet instrument en permettant de constater dans quelle mesure et à quelles conditions il peut aider à l'efficacité de la psychothérapie.

Cette possibilité d'instrumentation parallèle à la psychothérapie à travers un instrument est une des découvertes imprévues auxquelles nous a conduits l'élaboration des programmes d'Auto-développement. Il ne s'agissait pas d'un objectif au départ : c'est à l'occasion des nombreuses discussions rendues nécessaires par la mise au point du programme qu'est apparue l'idée d'utiliser les éléments du programme comme supports au travail fait en entrevue. Grâce à une mise à l'essai par un petit groupe de psychothérapeutes, il a été possible d'explorer les possibilités et les limites de cette façon de travailler, ainsi que les conditions générales de son efficacité. Ceci a permis de présenter aux professionnels un "Guide du psychothérapeute" pour les aider à bénéficier de cette expérience afin de mieux se servir du programme (Garneau, 1994). Nos recherches cliniques sont venues par la suite confirmer et préciser davantage les possibilités ainsi que les exigences de cette façon d'utiliser le programme.

B- "La lettre du Psy"

C'est aussi un peu par accident que nous avons développé cette autre façon d'intervenir à distance dans un but d'instrumentation. Notre préoccupation initiale était d'explorer les possibilités et limites du réseau Internet comme lieu d'intervention psychologique. Il s'agit en effet d'un moyen de communication d'une efficacité remarquable comparativement à tout ce que nous avons connu auparavant. À des coûts qui sont à la portée des masses, il est possible d'interagir avec une ou plusieurs personnes sans les limites habituelles de distances et de frontières. On peut donc envisager une intervention à distance encore plus efficace que par l'intermédiaire d'un ouvrage imprimé, d'un enregistrement ou d'un fax. Les frais d'impression sont nuls, les stocks sont inutiles, la distribution est instantanée, le support après vente est facile et rapide.

Pour une approche qui met l'accent sur l'instrumentation, un tel système apparaît comme un support particulièrement approprié : il permet de faire le travail répétitif d'information-entraînement à un coût minime pour le client, sans mobiliser chaque fois un professionnel pour s'en charger. On peut ainsi conserver les énergies du professionnel pour les parties plus délicates et difficiles du travail, tout en fournissant au client la possibilité de prendre lui-même en charge une partie importante de sa démarche. C'est en fait le même concept que celui qui avait conduit à l'élaboration des programmes d'auto-développement, mais sans les coûts et les complexités occasionnés par le support physique.

[1] Un résumé des résultats et des commentaires des utilisateurs du programme est disponible sur le réseau Internet à l'adresse suivante : <http://www.redpsy.com/temoigrs.html>.

C'est aussi une amélioration que nous espérions déjà dans la version sur papier du programme : un support professionnel facilement accessible partout en cas de besoin. La version sur papier exigeait la mise sur pied d'un réseau de professionnels couvrant toutes les régions où le programme était vendu, avec l'initiation nécessaire de chaque professionnel aux particularités de cet instrument. Il s'agissait d'un système bien lourd pour l'usage qu'en font réellement les clients. Avec les possibilités d'Internet, on peut envisager un support-dépannage dispensé par un petit nombre de professionnels très familiers avec le programme et capables de référer au besoin à des collègues qui se trouvent dans la région où habite le client. Ceci rend possible un support de meilleure qualité assuré par un petit nombre de spécialistes capables de répondre eux-mêmes à la majorité des besoins et capables d'identifier rapidement les situations qui exigent une aide plus approfondie.

Les possibilités de l'intervention à distance sont très réelles et variées. Les sollicitations sont nombreuses pour le faire; il suffit qu'un psychologue devienne visible sur Internet pour se retrouver rapidement interpellé par un grand nombre de personnes qui lui demandent conseil. Plusieurs professionnels offrent déjà diverses formes d'intervention psychologique par courrier électronique ou autrement (Ainsworth, 1998).

Mais nous voulions explorer cet univers inconnu avec toute la prudence nécessaire au respect de nos exigences professionnelles. C'est ce qui nous a amenés à envisager une intervention de nature éducative qui, par sa forme, permettait de bien tenir compte des principales limites connues du nouveau médium : l'absence des indices non-verbaux, la difficulté d'identifier réellement le client, les limites imposées à l'intervention d'urgence et l'impossibilité d'assurer au besoin la sécurité du client ou de son entourage. Nous avons donc opté pour une publication électronique destinée au grand public et visant à fournir aux individus des outils susceptibles de les aider à gérer eux-mêmes leur développement personnel.

Une telle publication constitue clairement une forme d'instrumentation. Des articles fournissent, dans un langage et sous une forme accessible à tous, des connaissances qui permettent de comprendre des réalités psychiques importantes et de connaître des façons appropriées d'y réagir. Le courrier électronique et la "page Web" correspondant à chaque article permettent aux individus de demander des précisions et d'obtenir des réponses de l'auteur de l'article. La section "coffre d'outils" propose des instruments particuliers avec les objectifs qu'ils aident à atteindre. "Le guide des émotions" fournit une information utile sur la nature et la fonction de diverses expériences émotives ou para-émotives, en proposant des façons de les exploiter adéquatement.

Notre découverte la plus important à l'occasion de cette expérience c'est qu'il est possible de présenter ainsi notre perspective humaniste d'une façon qui en respecte la richesse et les particularités plutôt que la version simpliste et peu informante à laquelle le public est généralement réduit, Plutôt que d'affirmer des généralités vagues dont seuls les spécialistes peuvent réellement saisir la portée, il est possible de faire voir concrètement en quoi consiste cette façon d'aborder les choses qui met la personne et sa liberté au centre des préoccupations. L'instrumentation devient également, dans ce

contexte, un concept qui évoque des réalités précises avec des formes concrètes et non plus une bonne intention vague. Il est extrêmement satisfaisant de constater que les clients sont, grâce à cet instrument, en mesure de choisir un professionnel qu'ils connaissent déjà un peu et dont la façon d'aborder les réalités psychologiques correspond à ce qu'ils recherchent. Aucun service de référence ne peut réaliser un meilleur pairage thérapeute-client.

Conclusion

Comme nous l'avons souligné depuis le début, notre pensée et notre pratique se sont raffinées en s'épurant avec le passage du temps et l'accumulation d'expérience. Nous estimons être maintenant plus profondément et plus lucidement humanistes, au-delà du courant social particulier qui a vu l'éclosion de cette orientation dans les années 60. Les psychologues humanistes-existentiels ne sont plus "à la mode" comme ils l'étaient alors; ils regroupent maintenant, comme les orientations psychodynamique et behavioriste, environ un tiers des psychologues québécois. Nous croyons que la distribution des psychologues dans les trois courants principaux de la psychologie est une situation plus saine du point de vue des intérêts de la population : cela assure des services basés sur des visions différentes de l'homme et de son évolution. Les clients peuvent plus facilement choisir le thérapeute qui correspond à leurs besoins, à leurs objectifs et à leur conception de la vie. Il suffit que les psychologues fournissent clairement l'information nécessaire à ces choix.

En tant qu'humanistes, nous sommes convaincus qu'il est important pour notre société d'avoir accès aux services de plusieurs écoles en psychologie. C'est ce qui nous amène à nous alarmer devant un phénomène relativement récent.

A- Une inquiétude

Depuis plusieurs années, nous observons un comportement inquiétant de la part de nos collègues qui s'identifient au courant humaniste. Nous espérons, en communiquant cette préoccupation à nos collègues, contribuer à une évolution saine du groupe des psychologues humanistes et, peut-être même, à la survie de cette importante option professionnelle.

Pour diverses raisons, un grand nombre de nos collègues humanistes ont tendance à adopter une approche éclectique qui, avec le temps, dissimule de plus en plus leur spécificité. Plutôt que de présenter clairement ce qui fait leur identité propre, ils intègrent dans leur pratique des éléments empruntés aux autres approches (Larivey, 1997). Au nom de l'efficacité et du réalisme scientifique, ils en viennent rapidement à adopter des méthodes et des façons d'aborder les problèmes qui sont réellement contradictoires avec une vision humaniste de la réalité psychique.

Cette "souplesse théorique" est nettement plus répandue chez les humanistes que chez les psychologues d'orientation psychodynamique ou behavioriste. Il en résulte une situation qui nous semble alarmante et mérite d'être examinée. C'est pourquoi nous présentons ci-dessous nos réflexions sur les raisons qui rendent les humanistes plus susceptibles de tomber dans ce piège et sur les forces qui les incitent à s'y lancer eux-mêmes. Notre vision de la solution la plus satisfaisante à ce problème viendra compléter cette conclusion.

1- Une question d'attitude

L'orientation psychodynamique est la plus ancienne et celle dont l'organisation est la mieux structurée. Le bagage historique contribue à fournir à ses membres une forme d'assurance quant à la pertinence des fondements de l'approche. Une hiérarchie bien établie permet de conserver une unité de pensée fondamentale à l'intérieur de laquelle la discussion et la recherche doivent s'insérer pour être crédibles.

Du côté des psychologues behavioristes, il est aussi relativement facile de faire preuve d'assurance lorsqu'il est question des fondements de leur approche et de ses méthodes. La science "officielle" les appuie clairement et leur permet de croire qu'ils sont seuls à travailler sur des problèmes et des solutions réels. En ce moment, particulièrement en Amérique du nord, ils apparaissent souvent aux yeux des organismes publics comme les seuls psychologues valables ou les seuls efficaces.

Mais les humanistes ont moins d'assurance et sont moins prêts à affirmer leur point de vue comme étant le seul valable. Leur option la plus fondamentale les amène à garder un esprit ouvert devant les perceptions des autres, à en rechercher la pertinence intrinsèque, à les considérer avec un respect qui s'apparente étrangement à celui qu'ils ont face à leurs clients. Il leur semblerait "dogmatique" ou "autoritaire" de penser ou d'agir autrement. Un humaniste, par définition, n'est jamais sûr de détenir la vérité; il est donc dans une position apparemment vulnérable lorsqu'il est confronté à des personnes qui affirment que leur point de vue est le seul valable.

De plus, il faut reconnaître qu'il est dans la nature profonde du courant humaniste, depuis ses débuts, d'être relativement peu organisé et peu structuré. C'est le courant où on observe la plus grande prolifération d'approches ou d'écoles de pensée; c'est celle où il est le plus difficile de créer une unité de pensée fondamentale à partir de laquelle construire. C'est aussi celle qui ne pourrait accepter facilement de se soumettre à une hiérarchie quelconque. La liberté individuelle, particulièrement celle de la pensée, est au coeur du choix de devenir humaniste; elle ne peut facilement s'accommoder d'une organisation où certaines personnes peuvent dicter à d'autres leur comportement ou, pire, leur pensée. De la même façon, les humanistes s'interdisent eux-mêmes d'influencer indûment l'opinion des autres, préférant toujours favoriser chez leur interlocuteur l'éclosion d'une pensée personnelle et d'une conviction réfléchie.

Nous pouvons tirer ici une première hypothèse de conclusion : les caractéristiques fondamentales de l'orientation humaniste font que les psychologues qui y adhèrent ont peu tendance à livrer à leur collègues des autres courants, les batailles de positionnement nécessaires. Ils ne cherchent pas volontiers à dominer ou contrôler le marché de la psychologie, mais privilégient naturellement un marché où toutes les options sont disponibles.

2- Un contexte économique

Mais il y a plus encore. La fin de la période d'abondance débridée des années 60-70 a touché la presque totalité des pays, l'Amérique du nord au moins autant que les autres. Les pouvoirs publics ont peu à peu décidé qu'ils n'avaient plus les moyens d'offrir tous les services qu'ils avaient promis auparavant. Ils en sont rapidement venus, par la nécessité budgétaire, à devoir redéfinir la mission et les offres des organismes qui dispensaient des services psychologiques à la population. On a d'abord limité le nombre d'entrevues offertes au C.L.S.C. pour les consultations psychologiques. De plus en plus, on a insisté sur la nécessité de mettre rapidement fin à la consultation psychologique, sans vraiment tenir compte des besoins réels du client. Les autres organismes ont peu à peu emboîté le pas et nous en sommes maintenant au point où la norme la plus répandue est de 5 entrevues ou moins pour une consultation psychologique offerte dans le cadre des programmes d'aide aux employés.

Comment faire une intervention réellement humaniste dans ces conditions? Comment être un thérapeute qui intervient en prenant en considération la personne dans son ensemble? Comment échapper, dans un tel contexte, à la consultation centrée sur la résolution d'un problème plutôt que sur l'épanouissement de la personne ?

Les services de santé en général, et les services psychologiques plus particulièrement sont maintenant gérés par des administrateurs dont les principaux critères sont financiers. Le phénomène est devenu si important qu'on assiste actuellement à la dénonciation publique du "managed care" aux États-unis : un système qui assurerait la richesse des compagnies d'assurance et de gestion au détriment des patients et même de leur sécurité. De plus en plus de psychologues américains refusent de travailler pour ces compagnies et développent une pratique où ils dispensent, à des clients qui paient eux-mêmes, des services qui ont la qualité appropriée, avec des critères éthiques adéquats et avec un respect réel des règles normales de confidentialité. Ils sont de plus en plus nombreux à refuser de rendre des comptes à des assureurs qui n'y comprennent rien pour se soumettre directement à l'autorité et au jugement de leurs clients (Zur, 1997).

Nous n'en sommes pas tout à fait là au Québec, mais il suffit de regarder la proportion de la clientèle des psychologues qui vient directement des organismes comme les programmes d'aide aux employés (PAE), la Commission de santé et sécurité au travail (CSST) ou l'Indemnisation des victimes d'actes criminels IVAC), pour constater que nous n'en sommes pas loin. Les honoraires sont dictés de façon unilatérale par ces organismes et la durée de l'intervention est décidée par des personnes qui n'ont

pas la formation professionnelle pour l'évaluer. Et comme les honoraires sont indépendants des qualifications des professionnels (et inférieurs aux taux normaux du marché), ce sont les professionnels les moins expérimentés ou les moins en demande qui acceptent le plus souvent de tenter de faire en 5 entrevues ce qui en demanderait une quinzaine à un expert chevronné.

Les nécessités de marketing, la surabondance de psychologues et la diminution du nombre d'emplois en psychologie font que plusieurs professionnels acceptent ces conditions même lorsqu'ils les considèrent comme inadéquates du point de vue de l'efficacité et même de l'éthique. Les humanistes sont probablement les plus vulnérables devant cette situation et ils ont tendance à emprunter les méthodes de résolution de problèmes qui semblent être efficaces dans les autres approches. Selon les règles de ce marché, il faut à tout prix obtenir plus de résultats à un moindre coût; la société n'a plus les moyens de se soucier des questions philosophiques.

Mais en essayant de répondre aux impératifs de la situation, on en vient rapidement à renoncer à tout ce qu'on connaît sur le processus de changement et sur les conditions nécessaires pour qu'il se mette en marche. Il n'est plus du ressort du psychologue de décider quel est le traitement adéquat pour un problème psychologique et combien de temps il durera; c'est une décision que la science des actuaires permet de prendre!

B- Une voie de solution possible

Il ne sera jamais acceptable pour un professionnel de laisser dénaturer ainsi son travail : l'éthique la moins exigeante s'y opposerait. C'est aux spécialistes du fonctionnement humain que revient le devoir d'évaluer la nature des problèmes psychiques, les traitements appropriés, le temps nécessaire et les critères de succès. Seul le client lui-même a le droit d'avoir préséance sur le point de vue du spécialiste.

Nous croyons qu'une partie importante de la solution au problème des services psychologiques réside dans un leadership ferme des spécialistes que sont les psychologues. S'ils affirment que les contraintes imposées par des administrateurs sont irréalistes, s'ils refusent de travailler dans des conditions qui ne respectent ni leur éthique ni leur compréhension du fonctionnement humain, ils assumeront ce leadership nécessaire.

Ils perdront probablement à court terme des mandats qu'ils n'auraient pu assumer adéquatement, mais ils obtiendront à moyen terme des conditions plus raisonnables. En peu de temps, lorsque les clients refuseront de recevoir des services qui ne répondent qu'à des impératifs économiques, ils pourront recommencer à faire leur travail d'une façon qui corresponde à leurs critères de qualité. C'est aux spécialistes de décider comment leur travail doit être fait.

Les humanistes sont des spécialistes d'un genre particulier, ceux qui estiment important de respecter

la personne humaine (leur client) et d'en faire le principal agent de son changement. Ils sont capables de développer des services appropriés à un contexte d'intervention à court terme sans perdre leur identité fondamentale. Ce n'est pas en empruntant des techniques dont les fondements sont contradictoires avec leurs options humanistes qu'ils y parviennent, c'est en revenant aux fondements de l'orientation humaniste-existentielle pour créer de nouvelles techniques. Ce n'est pas en étant humaniste "à l'occasion" qu'on peut fournir à nos clients la puissance d'une intervention qui change la suite de sa vie et en fait une personne plus complète; c'est en acceptant de ne pas répondre à toutes les demandes pour se consacrer au développement d'une intervention vraiment humaniste. Nous estimons que les travaux de St-Arnaud (1998) pour développer la "consultation ponctuelle" en sont un exemple éloquent.

Tout humaniste est "éclectique" au sens où il demeure ouvert à plusieurs visions des choses et où il reconnaît naturellement la valeur des autres façons d'aborder le réel. Les origines phénoménologiques de l'épistémologie caractéristique du courant humaniste en font presque une évidence. Mais la qualité du psychothérapeute humaniste exige une cohérence interne, une unité dans le message thérapeutique qui ne tolère pas les emprunts intempestifs. Une discussion plus élaborée de ces exigences a déjà été publiée par Jean Garneau (1984).

Références

AINSWORTH, Martha (1998). *Online Therapy*. Répertoire commenté de ressources disponibles sur Internet : <http://www.cmhcsys.com/guide/cyber/>.

ALLAIRE, F., COUILLARD, C. (1975). *Le temps d'apprendre.* Québec : Ministère de l'éducation.

BUGENTAL, J.F.T. (1965). *The Search for Authenticity : an existential-analytic approach to psychotherapy*. N.Y. : Holt, Rinehart and Winston.

GARNEAU, J. (1980). L'Auto-développement, in *Santé mentale au Québec*, V-I.

GARNEAU, J. (1984). L'Auto-développement : une stratégie d'instrumentation, *in Revue québécoise de psychologie*, Vol.5, No 3.

GARNEAU, J. (1994). *Guide du psychothérapeute : Savoir Ressentir.* Montréal : Ressources en Développement.

GARNEAU, J., LARIVEY, Michelle (1974). *Le processus de croissance.* Montréal : Institut de formation par le groupe (IFG) Document à circulation limitée.

GARNEAU, J., LARIVEY, Michelle (1979). *L'Auto-développement : psychothérapie dans la vie quotidienne*. Montréal : Ressources en Développement. (Épuisé)

GARNEAU, J., LARIVEY, Michelle (1983, 1997). *L'Auto-développement : psychothérapie dans la vie quotidienne*. Montréal : Éditions de l'homme.

GARNEAU, J. LARIVEY, Michelle (1996). *Effets du programme Savoir Ressentir sur la psychothérapie*. Montréal : XXVIe Congrès international de psychologie.

GARNEAU, J., LARIVEY, Michelle (1999). *Une théorie du vivant.* <http://www.redpsy.com/infopsy/vivant.html>.

GENDLIN, E.T. (1962). *Experiencing and the Creation of Meaning*. N.Y. : Free Press.

GENDLIN, E.T. (1964). A Theory of Personality Change, in P. Worchel et D. Byrne : *Personality change*. N.Y. : Wiley.

GODIN, E. (1975). *Construction d'un instrument de mesure sur le fonctionnement du processus de croissance*. Montréal : thèse de maîtrise inédite présentée à l'Université du Québec à Montréal.

LARIVEY, Michelle (1978). *Nature et fonction des émotions*. Montréal : Ressources en Développement. Document de formation à circulation limitée.

LARIVEY, Michelle (1996). *La complainte d'un humaniste*. <http://www.redpsy.com/images/humaniste.html>

LARIVEY, Michelle (1998). Les genres d'émotions, in *La lettre du Psy* Vol. 2, No 7. Montréal : Ressources en Développement. Aussi disponible à : <http://www.redpsy.com/infopsy/genremo.html>.

LARIVEY, Michelle (1999). Conquérir sa liberté, in *La lettre du Psy* Vol. 3, No 4. Montréal: Ressources en Développment. Aussi disponible à: <http://www.redpsy.com/infopsy/noeuds3.html>

MASLOW, A.H. (1954). *Motivation and Personalit*y. N.Y. : Harvard.

PERLS, F.S. (1947). *Ego, Hunger and Agression*. N.Y. : Random House.

PERLS, F.S. (1969). *In and Out the Garbage Pail*. Lafayette, CA : Real People Press.

ST-ARNAUD, Y. (1998). *L'intervention en psychologie des relations humaines*. La relation d'aide ponctuelle: chap. 13. Document non publié : Département de psychologie, Université de Sherbrooke.

ZUR, O. (1997). *Confession : Why I Developed The Seminars and Mail-Order Catalog*. : <http://www.drzur.com/confess.html>